가상 감염관리규정 (연습용)

개정일: 2026-01-01
※ 본 문서는 챗봇 테스트용 가상 자료입니다.

제1장 총칙

제1조(목적)
이 규정은 가상의 연습용 의료기관(이하 "본 기관"이라 한다)에서 의료관련 감염을 예방하고 환자와 직원의 안전을 지키기 위하여 필요한 감염관리 기준과 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의)
① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "손위생"이란 물과 비누를 이용한 손씻기와 알코올 손소독제를 이용한 손마찰을 모두 포함한다.
2. "개인보호구"란 장갑, 가운, 마스크, 보안경, 안면보호구 등 감염원으로부터 착용자를 보호하는 물품을 말한다.
3. "격리"란 감염원의 전파를 막기 위하여 환자를 일정한 공간에 분리하거나 접촉을 제한하는 조치를 말한다.
4. "감염관리 담당자"란 본 기관의 가상 감염관리실에 소속되어 감염관리 업무를 수행하는 직원을 말한다.
② 이 규정에서 정하지 않은 용어는 본 기관의 다른 가상 지침에서 정한 바에 따른다.

제3조(적용 범위)
① 이 규정은 본 기관의 모든 직원, 실습생, 용역 업체 직원 및 방문객에게 적용한다.
② 부서별 특성에 따라 세부 지침이 필요한 경우 부서장은 감염관리 담당자와 협의하여 별도 지침을 둘 수 있으며, 그 지침은 이 규정에 어긋나서는 안 된다.

제4조(감염관리 위원회)
① 본 기관은 감염관리에 관한 주요 사항을 심의하기 위하여 가상 감염관리 위원회를 둔다.
② 위원회는 분기마다 1회 정기 회의를 열고, 집단 발생이 의심되는 등 긴급한 사안이 있으면 위원장이 임시 회의를 소집한다.
③ 위원회는 손위생 수행률, 격리 현황, 보호구 사용 실태 등 가상 지표를 검토하고 개선 과제를 정한다.

제2장 손위생

제5조(손위생 원칙)
① 모든 직원은 환자 진료 구역에서 손위생을 가장 기본적인 감염관리 수단으로 실천한다.
② 손에 눈에 보이는 오염이 있거나 설사 증상이 있는 환자를 돌본 후에는 알코올 손소독제

대신 물과 비누로 손을 씻는다.

③ 손위생을 방해하지 않도록 진료 구역에서는 손톱을 짧게 유지하고 인조 손톱과 반지, 손목시계 착용을 삼간다.

제6조(손위생 시점)

① 직원은 다음의 다섯 시점에 반드시 손위생을 수행한다.

1. 환자 접촉 전: 환자의 몸에 닿거나 환자를 돕기 위해 다가가기 전에 손위생을 한다.
2. 청결 또는 무균 처치 전: 정맥주사 준비, 상처 드레싱, 카테터 처치 등 무균 조작을 시작하기 직전에 손위생을 한다.
3. 체액 노출 위험 후: 혈액, 체액, 분비물에 노출될 가능성이 있는 행위를 한 직후에는 장갑을 벗은 뒤 즉시 손위생을 한다.
4. 환자 접촉 후: 환자를 만지거나 돌보는 일을 마치고 환자 곁을 떠날 때 손위생을 한다.
5. 환자 주변 환경 접촉 후: 환자를 직접 만지지 않았더라도 침대 난간, 모니터, 수액 펌프 등 환자 주변 물품을 만진 후에는 손위생을 한다.

② 위 다섯 시점은 연습용 가상 예시이며, 부서 특성에 따라 추가 시점을 정할 수 있다.

제7조(손위생 방법)

① 알코올 손소독제를 사용할 때는 손바닥에 충분한 양을 덜어 손바닥, 손등, 손가락 사이, 엄지, 손톱 밑까지 문지르고, 손이 완전히 마를 때까지 약 20초에서 30초 동안 마찰한다.

② 물과 비누로 손을 씻을 때는 흐르는 물에 손을 적신 뒤 비누 거품을 내어 같은 부위를 꼼꼼히 문지르고, 약 40초에서 60초에 걸쳐 씻은 다음 일회용 종이타월로 물기를 닦는다.

③ 수도꼭지를 손으로 잠가야 하는 경우에는 사용한 종이타월로 잠가 손이 다시 오염되는 것을 막는다.

④ 위 시간은 교육용 가상 기준이며 실제 기준은 각 기관의 지침을 따른다.

제8조(손위생 점검)

① 감염관리 담당자는 매월 각 부서의 손위생 수행 여부를 직접 관찰하여 점검한다.

② 점검 결과는 부서별로 정리하여 부서장에게 전달하고, 수행률이 낮은 부서에는 재교육을 실시한다.

③ 점검은 개인을 처벌하기 위한 것이 아니라 부서의 습관을 개선하기 위한 것이며, 점검 결과에 개인 이름을 기재하지 않는다.

제3장 격리 및 보호구

제9조(격리 유형)

① 본 기관의 격리는 전파 경로에 따라 다음과 같이 구분한다.

1. 접촉주의 격리: 환자 또는 환자 주변 환경과의 직접, 간접 접촉으로 전파되는 감염원에 적용한다.
2. 비말주의 격리: 기침이나 재채기 등으로 생기는 큰 비말로 가까운 거리에서 전파되는

감염원에 적용한다.

3. 공기주의 격리: 공기 중에 오래 떠다니는 작은 입자로 먼 거리까지 전파되는 감염원에 적용하며, 음압 격리실 사용을 원칙으로 한다.

② 격리 유형은 담당 의사의 판단과 감염관리 담당자의 자문을 거쳐 정하고, 병실 출입문에 격리 유형별 색상 안내판을 부착한다.

③ 격리 환자의 이동은 검사나 치료 등 꼭 필요한 경우로 한정하며, 이동 시 도착 부서에 미리 알린다.

제10조(보호구 착용)

① 직원은 격리 병실에 들어가기 전에 격리 유형에 맞는 개인보호구를 착용한다.

② 보호구는 손위생, 가운, 마스크 또는 호흡기 보호구, 보안경 또는 안면보호구, 장갑의 순서로 착용한다.

③ 호흡기 보호구를 착용한 경우에는 매번 밀착 여부를 스스로 점검하고, 공기가 새는 경우에는 다시 착용한다.

④ 보호구가 찢어지거나 오염된 경우에는 즉시 병실 밖으로 나와 안전하게 벗고 새 보호구로 교체한다.

제11조(보호구 탈의)

① 보호구는 오염 가능성이 가장 높은 것부터 벗으며, 장갑, 보안경 또는 안면보호구, 가운, 마스크 또는 호흡기 보호구의 순서로 벗는다.

② 장갑과 가운은 병실 안 출입문 가까이에서 벗고, 마스크와 호흡기 보호구는 병실 밖이나 전실에서 끈을 잡아 벗는다.

③ 각 단계 사이에 손이 오염되었다고 의심되면 손위생을 하고, 모든 보호구를 벗은 뒤에는 반드시 손위생을 한다.

④ 사용한 보호구는 의료폐기물 전용 용기에 버리며 재사용하지 않는다.

제12조(격리 해제)

① 격리 해제는 담당 의사가 감염관리 담당자와 협의하여 결정한다.

② 격리가 해제되면 병실은 정해진 절차에 따라 환경 소독을 마친 후 다른 환자에게 배정한다.

③ 격리 기간과 해제 일시는 간호기록과 가상 감염관리 시스템에 함께 기록한다.

제4장 보칙

제13조(교육 및 훈련)

① 모든 신규 직원은 부서 배치 전 손위생과 보호구 착용, 탈의 교육을 이수한다.

② 감염관리 담당자는 연 1회 이상 전 직원을 대상으로 감염관리 교육을 실시하고, 보호구 착용 실습을 함께 진행한다.

제14조(시행일)

이 규정은 2026년 1월 1일부터 시행한다.